جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : نيفين على محمد نصار
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** خمسة عشر مايو **العنوان :** مممممممممم
رقم البطاقة : 27503012105341 **رقم التليفون :** 01141543332 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 01-03-1975 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: نيفين على محمد نصار
National ID: 27503012105341

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

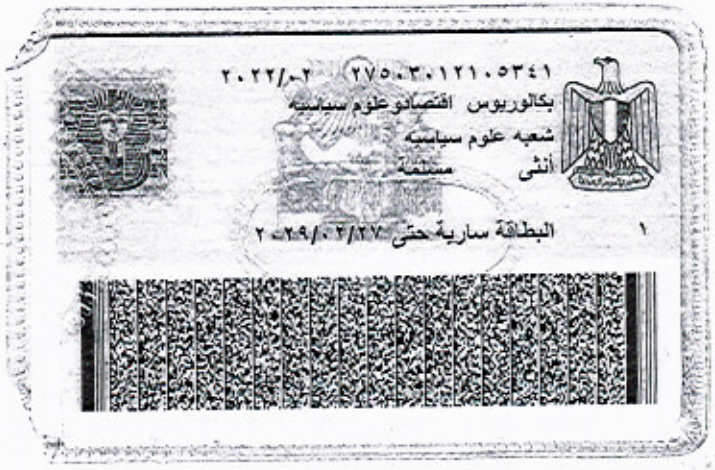
تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Patient Name	: الأستاذه / نيفين على محمد نصار	Request No.	: 13005615
Patient No.	: 27503012105341	Request Date	: 19/02/2022
ath No.	: 478/22	Verification Date	: 02/03/2022
ex	: Female	Financial Category	: اوراج دار السلام - تغطية الدولة
ge	: 46 Y	Department	: Out Patient
eferreing Doc	:	Registered by	: Ali mostafa

Pathology Report

Clinical Data:
Right breast mass (benign phylloids??), collected at 17/2/2022, 12.30 PM.

Nature of the specimen:
Right breast mass enucleation.

Gross Examination:
Procedure: Mass enucleation
Localization: Right breast
Tumor extent
Number: III defined breast tissue 10x7x2 cm, cut section showed friable graiysh white well defined mass 2x2 cm, reaching the margin grossly and 2 rubbery graiysh white nodular masses 1x1 cm each, also reaching the margins. Two separete breast tissue pieces 2x1 cm each with rubbery nodular graiysh white cut section.

Microscopic examination:
Histological type: Invasive lobular carcinoma inside fibroadenoma
Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): II (3+2+1)
Resection Margins: Positive involvement by invasive lobular carcinoma
Additional pathologic findings: Lobular insitu component 10%, positive perineural invasion

Diagnosis:
Right breast mass; Enucleation:
Invasive lobular carcinoma, grade II, inside fibroadenoma
Positive for margins involvement by invasive tumor
Case is for IPT (ER, PR, Her2, Ki67)

Prof.Dr. Aml Hareedy
Dr.Walaa Ghonaim

Verified by :
walaa ghoniem

غرفة رقم (4) - الدور الاول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name: نيفين على محمد **MR. :** 3121	

Detailed Medical Report

السيد	

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient was initially diagnosed with bilateral breast cancer and was started on hormonal therapy with Zoladex and Arimidex. Imaging at that time suggested equivocal liver lesions, but MRI characterized them as cystic. The most recent mammogram demonstrated residual disease in both breasts with bilateral axillary lymph nodes, prompting consideration of further diagnostic work-up.

The patient previously underwent right-sided breast-conserving surgery with axillary lymph node dissection. Subsequently, bilateral breast cancer was identified, with the left side not surgically addressed due to concern for metastatic bone and liver disease. Earlier bone scans did not confirm metastases, and a prior MRI of the pelvis did not demonstrate malignant hepatic focal lesions. The disease is now progressing locally despite hormonal therapy (Arimidex + Zoladex). In April 2026 the patient had bilateral skin-sparing mastectomy, which revealed pathological involvement of bilateral axillary lymph nodes, segmental hepatic lesions (segment III–IV) deemed stable disease, and stable bone lesions. Multimodality imaging (triphasic MRI, bone scan) will be reviewed, and if metastases are excluded, loco-regional treatment with bilateral modified radical mastectomy will be considered; if metastatic disease is confirmed, addition of a CDK 4/6 inhibitor may be contemplated after multidisciplinary discussion.

Dynamic MRI of the abdomen performed subsequently identified benign-appearing lesions in the femoral region, without evidence of malignant hepatic involvement.

A comprehensive review of all prior imaging demonstrated no definitive evidence of liver or bone metastases. The latest abdominal MRI showed multiple benign-looking hepatic focal lesions, and the bone scan was negative. The plan is to proceed with a new contrast-enhanced spectral mammography (CESM) and obtain biopsy from the bilateral axillary lymph nodes to further assess disease status and determine eligibility for radical treatment.

تحريرا في ,

التاريخ :	19-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : Ali Adel

يعتمد ,

Patient Name	: الاستاذه / نيفين على محمد نصار	Request No.	: 13005615
Patient No.	: 27503012105341	Request Date	: 19/02/2022
Path No.	: 478/22	Verification Date	: 22/03/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورانج دار السلام - نقابة الدولة
Age	: 46 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: Ali mostafa

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data:
Right breast mass (benign phylloids??), collected at 17/2/2022, 12.30 PM.

Nature of the specimen:
Right breast mass enucleation.

Gross Examination:
Procedure: Mass enucleation
Localization: Right breast
Tumor extent
Number: Ill defined breast tissue 10x7x2 cm, cut section showed friable graiysh white well defined mass 2x2 cm, reaching the margin grossly and 2 rubbery graiysh white nodular masses 1x1 cm each, also reaching the margins. Two separete breast tissue pieces 2x1 cm each with rubbery nodular graiysh white cut section.

Microscopic examination:
Histological type: Invasive lobular carcinoma inside fibroadenoma
Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): II (3+2+1)
Resection Margins: Positive involvement by invasive lobular carcinoma
Additional pathologic findings: Lobular insitu component 10%, positive perineural invasion

Diagnosis:
Right breast mass; Enucleation:
Invasive lobular carcinoma, grade II, inside fibroadenoma
Positive for margins involvement by invasive tumor
IPT(Appropriate tissue control were reviewed):
Immunohistochemical technique: Sections prepared from paraffin block for immune- staining using

Verified by :
abdelrahman ibrahim

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

atient Name	الأستاذه / نيفين على محمد نصار	Request No.	13005615
atient No.	27503012105341	Request Date	19/02/2022
th No.	478/22	Verification Date	22/03/2022
ax	Female	Financial Category	اورام دار السلام - نقابة الشرطة
ge	46 Y	Department	Out Patient
eferreing Doc.		Registered by	Ali mostafa

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

nch Mark ULTRA system for ER, PR,HER2, ER clone (SP1), PR clone (1E2), HER-2 CLONE (4B5), i67 (30-9)).
R: Strong nuclear reaction in 100% of tumour cells. Positive, score (8/8).
R: Strong nuclear reaction in 100% of tumour cells. Positive, score (8/8).
er-2: No membrane reaction in tumour cells. Negative, score 0.
67: 15%

of. Dr. Amal Hareedy
Walaa Ghonaim
Abdulrahman Ibrahim

Verified by :
abdelrahman ibrahim

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
إدارة الأشعة

Patient Name: Nevein Ali Mohamed Nassar	Date : 31/10/2024
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 49 Year(s)
Medical ID: 3587/2021	Pat. ID: 11817

- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Still noted bulky uterus showing few focal calcified fibroids.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- Stable diffuse sclerotic metastatic deposits.

Opinion:

- **Right hepatic lobe segment VIII enahncing focal lesion of indeterminate nature for further Dynamic MRI liver assessment.**
- **Tiny segment V and VIII non enhancing focal lesions.**
- **Stationary rest of the study.**

Dr. Ali Elsisy, MSc.

Prof. Menna Tallah Hanafy, M.D.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان

MDT form

A-Patient ID:
1- Name : تراتين على محمد نصار
Sex: Female
3- Medical number: 83029186
Old Med : 3587-2021
2-ID number: 27503012105341
Patient Age : 48 Y

Family history		Phone	01141543332	BMI		REASON OF MDT	
marital status		NRS Score		GROUP		Date of MDT	15/05/2024
Co morbidity		Menopausal status		Initial STAGE			

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :
bone scan:non specific
ct:diffuse heterogenous texture of axilla+ appendicular skeleton

BX	ER	PR	Her 2 Neu	SISH	Ki67
ILC	8/8	8/8	0		

T	N	M
rt:3 lt:3	2 2	1(bone)

Sonomammography

PATIENT HISTORY
KNOWN BIL BREAST CANCER,,CTCAP-->RD OF LT AXLNS
started AI+zoladex 6/2022--> follow up
PT ON aramdix +zoladex

MDT OUTCOME & PLAN

FOR assessment ct cap if refused by MOH , reassess by ct & bone scan

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY		RADIOLOGY	
SURGERY		PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

نيفين
على محمد نصار
ق ١٧٤ م ٢ الاسكان الاجتماعى
خمسه عشر مايو - القاهره

٢٧٥٠٣٠١٢١٠٥٣٤١

١٩٧٥/٠٣/٠١

JH1978748

National ID · Front
[[DOCTYPE:ID_FRONT]]

[[DOCTYPE:MDT_FORM]]
MDT Form

جوستاف روسي

مبـــادرة رئيس الجمهوريـة
لدعـم صحة المرأة المصرية

09/29/2026

MDT FORM

Name:	Niveen Ali Mohamed	**MRN:**	3121
Age:	52 Y	**ID:**	27503012105341
Menopausal Sta	post	**Phone:**	01141543332
NRS SCORE:		**Marital Status:**	
BMI:		**Family History:**	
CO Morbidity:	free	**Reason Of MDT:**	

Clinical Data:

BX:

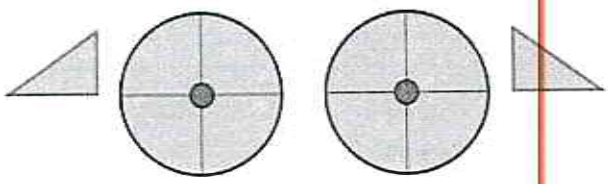
ER: **PR:** **HER2:** **KI67:**

Sonomammography:
CESM 18/8/2026 >> LT breast mass extend from parareolar to axillary tail0.9*0.7cm with pathological level I & II largest in level I 2.7*1.4cm & largest in level II 1.4*0.7cm + pathological lt supraclavicular 0.5*0.4cm
RT breast showing small sun centimetric nodules in operative bed + pathological level I axillary LNs + RT supraclavicular 0.9*0.7cm

Mets Workup:
dynamic MRI liver 24/6/2026 >> multiple benign looking hepatic focal lesions most likely simple cyst
bone scan 3/7/2026 >> free of mets
new ct cap will be done

History:
52 yo female pt, known case of bilateral breast cancer since 2022 ER 8/8, PR8/8, HER2 0. treated as mets to bones with 1st line hormonal ttt aramidex from 6/2022 until now.
pt underwent new bx (taken at صحة المرأة) from RT breast mass >> Invasive lobuler carcinoma ER 8/8, PR 0/8, HER2 0, ki 2% and from LT retroarolar and LT axillary tail mass >> invasive lobular carcinoma ER 8/8, PR 0/8, HER2 0 ki 2% with both -ve PNI, LVIS and micro calcification
and new bx taken her at our center from LT axillary LNs >> lymphoid tissue +ve for mets carcinoma ER 2/8, pr 3/8, her2 +2 equivocal (sish: not amplified)

R L



TNM

Recommendations:

MDT Outcome & Plan
For new CT CAP + bone window
If free --> Rt completion mastectomy + Left MRM (after surgical review)

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د خالد عبد العزيز	د محمد تيراوي				